SURVIVAL OS

# Guía de emergencia

Protocolos de primeros auxilios y actuación ante emergencias para consultar sin electricidad ni conexión.

**112**

**Ante una emergencia, llama al 112**

Número gratuito de emergencias en toda la Unión Europea. Di qué ha pasado, dónde estás y cuántas personas hay afectadas.

> Esta herramienta no sustituye la atención sanitaria profesional ni las indicaciones de los servicios de emergencia.

| GENERADA | PROTOCOLOS | CATEGORÍAS |
| --- | --- | --- |
| lun, 9 nov 2026 | 41 | 5 |

ÍNDICE

## Primeros auxilios


| | |
|---|---|
| 1 | Ante una emergencia: Proteger, Avisar, Socorrer |
| 2 | RCP en adultos (reanimación cardiopulmonar) |
| 3 | Hemorragia grave |
| 4 | Atragantamiento en adultos |
| 5 | Quemaduras |
| 6 | RCP en niños y lactantes |
| 7 | Uso del desfibrilador (DEA) |
| 8 | Posición lateral de seguridad |
| 9 | Atragantamiento en niños y lactantes |
| 10 | Ictus: reconocer y actuar |
| 11 | Dolor torácico (posible infarto) |
| 12 | Reacción alérgica grave (anafilaxia) |
| 13 | Convulsiones (crisis epiléptica) |
| 14 | Shock (fallo circulatorio) |
| 15 | Golpe en la cabeza (traumatismo craneal) |
| 16 | Sospecha de lesión de columna |
| 17 | Fracturas y esguinces |
| 18 | Heridas y prevención de la infección |
| 19 | Quemaduras químicas y eléctricas |

**20** Bajada de azúcar (hipoglucemia)

**21** Ahogamiento

**22** Deshidratación y suero oral casero

**Clima**

**23** Hipotermia

**24** Golpe de calor

**25** Congelación

**26** Ola de frío y refugio

**Agua**

**27** Potabilizar agua

**Intoxicaciones y picaduras**

**28** Intoxicación por monóxido de carbono

**29** Intoxicación por productos, medicamentos o setas

**30** Mordedura de víbora o serpiente

**31** Picaduras de abeja y avispa; garrapatas

**32** Mordeduras de animales (rabia y tétanos)

**Desastres y entorno**

**33** Incendio en casa o en un edificio

**34** Incendio forestal

**35** Terremoto

**36** Inundación

**37** Tormenta eléctrica y rayos

**38** Apagón prolongado

**39** Fuga u olor a gas

**40** Kit de emergencia para 72 horas

**41** Pedir ayuda y señales de socorro

1

PRIMEROS AUXILIOS

# Ante una emergencia: Proteger, Avisar, Socorrer

112

> Resumen orientativo. No sustituye a la formación en primeros auxilios ni a las instrucciones del 112.

## 1. Proteger

- Comprueba que **tú** no corres peligro (tráfico, fuego, electricidad, derrumbe, agua). No te conviertas en otra víctima.
- Si es seguro, aleja a la víctima del peligro solo si no puede quedarse donde está.

## 2. Avisar

- Llama al **112** (número único de emergencias en la UE).
- Di **qué** ha pasado, **dónde** (coordenadas del GPS si las tienes), **cuántas** víctimas hay y su estado (¿responden?, ¿respiran?).
- No cuelgues hasta que te lo indiquen. Pon el altavoz para tener las manos libres.

## 3. Socorrer

- ¿Responde? Háblale en voz alta y tócale los hombros.
- ¿Respira con normalidad? Mira, escucha y siente durante no más de 10 segundos.
- **No responde y no respira con normalidad** → RCP (protocolo «RCP en adultos»).

- **No responde pero respira** → posición lateral de seguridad y vigila la respiración.
- Hemorragia grave → presión directa inmediata (protocolo «Hemorragia grave»).

## Advertencias

- No des de comer ni de beber a una persona con el nivel de consciencia alterado.
- No muevas a una víctima de un traumatismo salvo peligro inminente.

---

**Fuente:** Consejo Europeo de Resucitación (ERC), Guías 2021 — Primeros auxilios; Servicio 112 (UE) · **Revisado:** 2026-11-08

2

PRIMEROS AUXILIOS

# RCP en adultos (reanimación cardiopulmonar)

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2021. La formación práctica es imprescindible.

## Cuándo

La persona **no responde** y **no respira con normalidad** (las boqueadas no son respiración normal).

## Pasos

1. Llama al **112** (altavoz) y pide un **DEA** (desfibrilador) si hay uno cerca.
2. Coloca a la víctima boca arriba sobre una superficie firme.
3. Pon el talón de una mano en el **centro del pecho**, la otra encima y los brazos rectos.
4. Comprime **5–6 cm** de profundidad a **100–120 compresiones por minuto**. Deja que el pecho se eleve del todo entre compresiones.
5. Si sabes y quieres hacerlo: **30 compresiones y 2 insuflaciones**. Si no, solo compresiones continuas.
6. En cuanto llegue el DEA: enciéndelo y sigue sus instrucciones de voz.
7. No pares hasta que llegue ayuda profesional, la víctima respire con normalidad o quedes agotado. Si hay otra persona, turnaos cada 2 minutos.

## Advertencias

- Interrumpe las compresiones lo menos posible.
- Se pueden romper costillas; no es motivo para parar.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Soporte vital básico en adultos ·
**Revisado:** 2026-11-08

3

PRIMEROS AUXILIOS

# Hemorragia grave

112

> Resumen orientativo. Una hemorragia grave puede ser mortal en minutos: actúa rápido.

## Pasos

1. Protégete si es posible (guantes o una bolsa de plástico).
2. Llama al **112**.
3. Aplica **presión directa firme** sobre la herida con un apósito, gasa o tela limpia, de forma continua.
4. Si la sangre empapa el apósito, **no lo retires**: añade más encima y sigue presionando.
5. Hemorragia potencialmente mortal **en un brazo o una pierna** que no se controla con presión directa: aplica un **torniquete** 5–7 cm por encima de la herida (nunca sobre una articulación) y apriétalo hasta que deje de sangrar. **Anota la hora** de colocación.
6. Abriga a la víctima y vigila su consciencia y su respiración.

## Advertencias

- No retires un torniquete una vez colocado: lo hará el personal sanitario.
- No extraigas objetos clavados; presiona alrededor e inmovilízalos.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (control de hemorragias) · **Revisado:** 2026-11-08

4

PRIMEROS AUXILIOS

# Atragantamiento en adultos

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2021.

## Si puede toser

- Anímale a **seguir tosiendo**. No hagas nada más y vigila.

## Si no puede toser, hablar ni respirar bien

1. Inclínale hacia delante y dale hasta **5 golpes** firmes en la espalda, entre los omóplatos, con el talón de la mano.
2. Si no se resuelve: hasta **5 compresiones abdominales** (maniobra de Heimlich). Desde detrás, coloca el puño entre el ombligo y el esternón y tira hacia dentro y hacia arriba.
3. Alterna 5 golpes y 5 compresiones hasta que se resuelva o pierda el conocimiento.
4. Si pierde el conocimiento: llama al **112** e inicia la **RCP**.

## Advertencias

- Tras unas compresiones abdominales, la persona debe ser valorada por un médico aunque se recupere.
- En embarazadas y personas con obesidad: compresiones en el pecho en lugar del abdomen.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño · **Revisado:** 2026-11-08

5

PRIMEROS AUXILIOS

# Quemaduras

112

> Resumen orientativo.

## Pasos

1. Aleja a la persona de la fuente de calor.
2. **Enfría con agua** limpia a temperatura ambiente o fresca durante **al menos 20 minutos**, lo antes posible.
3. Retira anillos, relojes y la ropa no adherida antes de que la zona se hinche.
4. Cubre la quemadura con **film transparente** (sin apretar) o con un apósito limpio no adherente.
5. Llama al **112** si es extensa o profunda, si afecta a la cara, las manos, los genitales o las vías respiratorias, o si es eléctrica o química.

## Advertencias

- **No** uses hielo, pasta de dientes, aceites ni remedios caseros.
- No revientes las ampollas.
- Vigila la hipotermia al enfriar quemaduras extensas, sobre todo en niños.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (quemaduras térmicas) · **Revisado:** 2026-11-08

# RCP en niños y lactantes



> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. La formación práctica es imprescindible. Lactante: menor de 1 año. Si parece un adolescente o un adulto, usa el protocolo «RCP en adultos».

## Cuándo

El niño **no responde** y **no respira con normalidad**. Ante la duda, actúa como si no respirara.

## Pasos

1. Comprueba que la zona es segura. Háblale en voz alta y tócale; no uses estímulos dolorosos.
2. Llama al **112** con el **altavoz** (o que llame otra persona) y sigue las instrucciones del operador. Si estás solo y sin teléfono, haz **1 minuto de RCP** antes de ir a pedir ayuda.
3. Abre la vía aérea: una mano en la frente y dos dedos bajo el mentón. En lactantes, cabeza en **posición neutra** (poco inclinada); en niños mayores, algo más inclinada.
4. Da **5 insuflaciones de rescate** iniciales, de 1 segundo cada una, lo justo para que el pecho se eleve. En lactantes, cubre con tu boca **su boca y su nariz**.
5. Comprime en la **mitad inferior del esternón**, al menos **un tercio de la profundidad del pecho** (unos 4 cm en lactantes y 5 cm en niños; nunca más de 6 cm), a **100–120 compresiones por minuto**. Deja que el pecho se eleve del todo.

6. Técnica: en lactantes, **rodea el tórax con las dos manos y comprime con los dos pulgares**; en niños, con **una o dos manos** según su tamaño.
7. Continúa con **30 compresiones y 2 insuflaciones** (15:2 solo si tienes formación específica en RCP pediátrica). Si no puedes o no quieres insuflar, haz solo compresiones.
8. Que otra persona traiga y conecte un **DEA** en cuanto sea posible (protocolo «Uso del desfibrilador (DEA)»). No pares hasta que llegue ayuda profesional o el niño muestre signos claros de vida.

## Advertencias

- Si el pecho no se eleva al insuflar: recoloca la cabeza y retira solo lo que veas en la boca. **No** hagas barridos a ciegas con el dedo.
- Si no responde pero respira con normalidad y no hay traumatismo: posición lateral de seguridad y comprueba la respiración al menos cada minuto.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Soporte vital pediátrico; ERC Guidelines 2021 — Soporte vital pediátrico · **Revisado:** 2026-11-09

7

PRIMEROS AUXILIOS

# Uso del desfibrilador (DEA)

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. El DEA es seguro: solo descarga si detecta un ritmo que lo necesita. La formación práctica es muy recomendable.

## Cuándo

La persona **no responde y no respira con normalidad**. Úsalo junto con la RCP.

## Pasos

1. Que alguien llame al **112** y otra persona traiga el **DEA** más cercano (el 112 puede decirte dónde hay uno). **No interrumpas la RCP** mientras llega.
2. **Enciéndelo** (abre la tapa o pulsa el botón) y sigue sus **instrucciones de voz**.
3. Descubre el pecho; si está mojado, **sécalo**. Aparta el sujetador si estorba.
4. Pega los parches: uno **bajo la clavícula derecha**, junto al esternón, y otro en el **lado izquierdo, bajo la axila**. No los pongas sobre el tejido mamario.
5. Niños de menos de **25 kg** (unos 8 años): activa el **modo pediátrico** si existe y pon un parche en el centro del pecho, algo a la izquierda, y el otro en la espalda, **entre los omóplatos**. Si no hay modo pediátrico, úsalo en modo adulto.
6. Mientras analiza el ritmo: **que nadie toque** a la víctima.

7. Si indica descarga: comprueba que nadie la toca y **pulsa el botón** (algunos modelos descargan solos).
8. Tras la descarga, o si no la indica, **reanuda la RCP de inmediato** y sigue las instrucciones. No retires los parches ni apagues el DEA.

## Advertencias

- Cada minuto de retraso en la desfibrilación reduce la probabilidad de supervivencia en torno a un 10 %: no esperes a estar seguro para usarlo.
- Tras un ahogamiento: saca a la víctima del agua y seca el pecho antes de pegar los parches.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Soporte vital básico en adultos y Soporte vital pediátrico; ERC — Guías 2025 de reanimación para la ciudadanía · **Revisado:** 2026-11-09

8

PRIMEROS AUXILIOS

# Posición lateral de seguridad

112

> Resumen orientativo de las guías ERC. Mantiene abierta la vía aérea de quien no responde pero respira. La formación práctica es muy recomendable.

## Cuándo

La persona **no responde** pero **respira con normalidad**, y **no** hay sospecha de traumatismo (caída, accidente).

## Pasos

1. Llama al **112**.
2. Arrodíllate a su lado, con la víctima boca arriba y las piernas estiradas. Quítale las gafas y los objetos voluminosos de los bolsillos.
3. Coloca el **brazo más cercano** a ti en ángulo recto con el cuerpo (estirado o doblado).
4. Pasa el **otro brazo** por encima del pecho y apoya el dorso de su mano contra su **mejilla** más cercana a ti. Sujétala ahí.
5. Con tu otra mano, **dobla la rodilla más lejana**, con el pie apoyado en el suelo.
6. **Tira de esa rodilla hacia ti** para girarla de lado, sin soltar la mano de la mejilla.
7. Ajusta la pierna de arriba para que la cadera y la rodilla queden en ángulo recto.
8. **Inclina la cabeza hacia atrás** para mantener abierta la vía aérea, con la mano bajo la mejilla.

9. **Comprueba la respiración** de forma continua. Si deja de respirar con normalidad, ponla boca arriba e inicia la **RCP**.

## Advertencias

- **No** la uses si respira de forma anormal (boqueadas) ni si hay traumatismo: en ese caso no la muevas salvo peligro.
- Si debe seguir así más de 30 minutos, gírala hacia el otro lado para aliviar la presión sobre el brazo de abajo.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (posición lateral de seguridad); ERC Guidelines 2021 — Soporte vital básico en adultos; Resuscitation Council UK — Recovery position · **Revisado:** 2026-11-09

9

PRIMEROS AUXILIOS

# Atragantamiento en niños y lactantes

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. La formación práctica es imprescindible. Lactante: menor de 1 año.

## Si puede toser, llorar o hablar

- Anímale a **seguir tosiendo**. Vigílale y no le golpees.

## Si no puede toser, llorar ni respirar bien

1. Que alguien llame al **112** (o llama tú con el altavoz).
2. **Lactante**: ponlo **boca abajo sobre tu antebrazo**, apoyado en tu muslo, sujetándole la cabeza con la mano y con la cabeza **más baja que el pecho**. Da hasta **5 golpes** firmes en la espalda, entre los omóplatos.
3. Si no se resuelve: ponlo **boca arriba** sobre tus muslos, rodea su tórax con las manos y da hasta **5 compresiones torácicas** con los **dos pulgares** sobre el esternón, más bruscas que en la RCP.
4. **Niño (mayor de 1 año)**: inclínalo hacia delante y da hasta **5 golpes** en la espalda, entre los omóplatos.
5. Si no se resuelve: colócate detrás, rodéale con los brazos, inclínalo hacia delante, pon el **puño entre el ombligo y el final del esternón** y tira bruscamente **hacia dentro y hacia arriba**, hasta **5 veces**.
6. Alterna 5 golpes y 5 compresiones mientras siga consciente. **Para** en cuanto tosa, llore o respire.

7. Si **deja de responder**: llama al 112 si nadie lo ha hecho e inicia la **RCP** (protocolo «RCP en niños y lactantes»).

## Advertencias

- **No** hagas barridos a ciegas con el dedo en la boca; retira solo un objeto que veas con claridad y puedas coger con facilidad.
- **Nunca** hagas compresiones abdominales a un lactante.
- Tras compresiones abdominales o torácicas, debe valorarle un médico aunque se recupere.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Soporte vital pediátrico (obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño) · **Revisado:** 2026-11-09

10

PRIMEROS AUXILIOS

# Ictus: reconocer y actuar

112

> Resumen orientativo. En el ictus cada minuto cuenta: el tratamiento depende de llegar pronto al hospital.

## Signos (aparecen de forma súbita)

- **Cara**: un lado de la boca se cae al sonreír.
- **Brazo**: no puede levantar los dos brazos, o uno cae.
- **Habla**: habla rara, arrastra las palabras o no entiende lo que se le dice.
- También: pérdida brusca de visión, dolor de cabeza muy intenso y repentino, mareo o falta de equilibrio sin causa.

## Pasos

1. Si aparece **cualquiera** de estos signos, llama al **112** de inmediato y di que sospechas un **ictus**.
2. **Anota la hora** en que empezaron los síntomas o la última vez que se le vio bien.
3. Mantén a la persona tranquila, sentada o tumbada en una postura cómoda, y aflójale la ropa.
4. Si no responde pero respira: **posición lateral de seguridad**. Si no respira con normalidad: **RCP**.
5. Reúne su medicación habitual o la lista de medicamentos para entregarla a los sanitarios.
6. No la dejes sola y vigila su consciencia y su respiración hasta que llegue la ayuda.

## Advertencias

- **No** le des comida, bebida ni medicamentos (tampoco aspirina): puede atragantarse y algunos ictus son hemorragias.
- **No** esperes a ver si se le pasa: aunque los síntomas desaparezcan, llama igualmente.
- Si es posible, no la lleves por tu cuenta: el 112 activa el «Código Ictus» y la traslada al hospital adecuado.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (accidente cerebrovascular); Sociedad Española de Neurología — Código Ictus; Ministerio de Sanidad — Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud · **Revisado:** 2026-11-09

11

PRIMEROS AUXILIOS

# Dolor torácico (posible infarto)

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. No intentes diagnosticar: ante la duda, trátalo como una emergencia. La formación en primeros auxilios es recomendable.

## Signos de alarma

Dolor u **opresión en el pecho** que puede extenderse al cuello, la mandíbula, la espalda o el brazo izquierdo, a menudo con sudor frío, falta de aire, náuseas o mareo. A veces los síntomas son menos claros.

## Pasos

1. Llama al **112** de inmediato.
2. Que **deje de hacer esfuerzos**: siéntala o túmbala en la postura en la que esté más cómoda. Tranquilízala.
3. Si es un adulto consciente con un dolor que parece de **origen cardíaco**, **no es alérgico a la aspirina** y el 112 no indica lo contrario, anímale y ayúdale a que **mastique** él mismo una aspirina (150–300 mg) lo antes posible mientras espera la ambulancia.
4. Si tiene **angina diagnosticada**, ayúdale a tomar su propia **nitroglicerina** (spray o comprimido) como se la prescribieron.
5. Afloja la ropa ajustada y **no la dejes sola**.
6. Localiza un **DEA** cercano por si fuera necesario.
7. Si deja de responder y no respira con normalidad: **RCP** y DEA.

## Advertencias

- **No** dejes que conduzca ni la lleves por tu cuenta si puedes esperar a la ambulancia.
- Informa al 112 de su medicación habitual (por ejemplo, anticoagulantes) antes de darle aspirina.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (dolor torácico) y Soporte vital básico en adultos; ERC — Guías 2025, Resumen ejecutivo (traducción oficial al castellano) · **Revisado:** 2026-11-09

12

PRIMEROS AUXILIOS

# Reacción alérgica grave (anafilaxia)

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. La anafilaxia puede ser mortal en minutos: la adrenalina es el tratamiento de primera elección. Aprende a usar el autoinyector antes de necesitarlo.

## Signos

Tras un alimento, una picadura o un medicamento: dificultad para respirar, **pitidos** o ronquera, **hinchazón de labios, lengua o garganta**, ronchas o enrojecimiento, mareo o desmayo, piel fría y pegajosa, vómitos o dolor abdominal.

## Pasos

1. Llama al **112** y di «**anafilaxia**».
2. Si tiene un **autoinyector de adrenalina prescrito**, úsalo **de inmediato** en la **cara externa del muslo** siguiendo las instrucciones del dispositivo (puede ponerse sobre la ropa). Si lo que tiene prescrito es adrenalina **nasal**, úsala.
3. Postura: si le cuesta respirar, **sentada**; si está mareada o pálida, **tumbada** con las piernas elevadas. **No la pongas de pie** ni la hagas caminar.
4. Si los síntomas **no mejoran a los 5 minutos**, administra una **segunda dosis** si hay otro autoinyector.
5. Retira el desencadenante si es posible (aguijón, dejar de comer).
6. Anota la hora de cada dosis y no la dejes sola: los síntomas pueden **reaparecer** horas después.

7. Si deja de responder y no respira con normalidad: **RCP**.

## Advertencias

- **No** esperes a ver si mejora para usar la adrenalina: ante la duda, úsala.
- Los antihistamínicos y los inhaladores **no sustituyen** a la adrenalina.
- Aunque mejore, debe ir al hospital.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (anafilaxia); Resuscitation Council UK — Emergency treatment of anaphylaxis (2021) · **Revisado:** 2026-11-09

13

PRIMEROS AUXILIOS

# Convulsiones (crisis epiléptica)

112

> Resumen orientativo. La mayoría de las crisis ceden solas en pocos minutos.

## Pasos

1. **Mantén la calma** y **mira la hora**: cronometra la crisis.
2. **Aparta** los objetos peligrosos y protege su cabeza con algo blando (una chaqueta doblada).
3. Aflójale la ropa del cuello y quítale las gafas.
4. **No la sujetes** ni intentes frenar los movimientos.
5. Cuando cesen los movimientos, colócala en **posición lateral de seguridad** y comprueba que **respira con normalidad**.
6. Quédate con ella hasta que esté totalmente despierta; es normal que esté confusa un rato.
7. Llama al **112** si la crisis dura **5 minutos o más**, si se repite sin recuperarse entre crisis, si es la **primera vez**, si se ha herido, si ha ocurrido en el **agua**, si está embarazada o tiene diabetes, o si no recupera la consciencia o le cuesta respirar.

## Advertencias

- **No** metas nada en su boca (ni dedos, ni objetos, ni líquidos): no se va a «tragar la lengua».
- No le des de comer ni de beber hasta que esté totalmente recuperada.

- Si después **no respira con normalidad**: RCP. Una parada cardíaca puede empezar con movimientos parecidos a una convulsión.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Soporte vital básico y Soporte vital pediátrico; Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE) y Epilepsy Foundation — Primeros auxilios en crisis epilépticas · **Revisado:** 2026-11-09

14

PRIMEROS AUXILIOS

# Shock (fallo circulatorio)

112

> Resumen orientativo. El shock es un fallo de la circulación (por hemorragia, alergia grave, infección o problema cardíaco) y requiere atención urgente.

## Signos

Piel **pálida, fría y sudorosa**, pulso muy rápido o muy lento, respiración rápida, mareo, sed, confusión o somnolencia.

## Pasos

1. Llama al **112**.
2. Trata la causa si la conoces: **hemorragia** → presión directa; **anafilaxia** → autoinyector de adrenalina.
3. **Túmbala boca arriba**.
4. Si no hay lesión en piernas, cadera, cabeza o columna, puedes **elevarle las piernas** de forma pasiva mientras esperas.
5. **Abrígala** por encima y aíslala del suelo para evitar que pierda calor.
6. Tranquilízala, no la dejes sola y **vigila** su consciencia y su respiración.
7. Si deja de responder pero respira: **posición lateral de seguridad** (si no hay traumatismo). Si no respira con normalidad: **RCP**.

## Advertencias

- **No** le des de comer ni de beber.

- No la levantes ni la hagas caminar.
- Si al tumbarla le cuesta más respirar, déjala semisentada.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (evaluación ABCDE de la persona enferma, lesionada o en shock); ERC Guidelines 2021 — Primeros auxilios (posición ante el shock) · **Revisado:** 2026-11-09

15

PRIMEROS AUXILIOS

# Golpe en la cabeza (traumatismo craneal)

112

> Resumen orientativo. Tras un golpe en la cabeza, los signos de gravedad pueden aparecer horas después.

## Pasos

1. Si **no responde**: llama al **112**. Si respira, **no la muevas** salvo peligro (puede haber lesión de columna). Si no respira con normalidad: **RCP**.
2. Si está consciente, que **deje de inmediato** toda actividad física o deportiva.
3. Si sangra el cuero cabelludo, **presiona** con un apósito limpio. Si notas un hundimiento del hueso, presiona alrededor, no encima.
4. Aplica **frío** envuelto en un paño sobre el chichón.
5. Llama al **112** si hay: pérdida de consciencia (aunque sea breve), **vómitos repetidos**, dolor de cabeza que **empeora**, somnolencia o confusión, **convulsiones**, pupilas de distinto tamaño, debilidad u hormigueo en brazos o piernas, salida de líquido o sangre por la nariz o los oídos, o si toma **anticoagulantes**.
6. Aunque parezca leve, que la valore un sanitario y que **alguien se quede con ella** al menos las primeras 24 horas.

## Advertencias

- No le des alcohol ni sedantes.
- Que no vuelva al deporte hasta que lo autorice un profesional sanitario.

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (conmoción cerebral); NICE — Head injury: assessment and early management (NG232, 2023); NHS — Head injury and concussion · **Revisado:** 2026-11-09

# Sospecha de lesión de columna

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. Ante la duda, trata a la víctima como si tuviera una lesión de columna. La formación práctica es muy recomendable.

## Cuándo sospecharla

Caída o salto desde altura, **zambullida** en aguas poco profundas, accidente de tráfico o deportivo, aplastamiento por maquinaria o un objeto pesado. Dolor de cuello o espalda, hormigueo o debilidad en brazos o piernas.

## Pasos

1. Llama al **112**.
2. **No la muevas** salvo peligro inminente (fuego, tráfico, agua).
3. Si está despierta: pídele que **no mueva el cuello** y lo mantenga en una posición cómoda y estable. **Nunca** la fuerces a adoptar una postura.
4. Si no responde y está boca arriba: arrodíllate detrás de su cabeza y **sujétala con ambas manos**, alineada con el cuerpo.
5. Si necesitas abrir la vía aérea, adelanta la mandíbula (**tracción mandibular**) moviendo el cuello lo mínimo.
6. Si está boca abajo y respira, mantén estable su cuello. Si hay que girarla para abrir la vía aérea o hacer RCP, hazlo **en bloque** entre varias personas, con cabeza, cuello y tronco alineados.
7. Si no respira con normalidad: **RCP**. La reanimación tiene prioridad sobre la protección de la columna.

8. Abrígala y vigílala hasta que llegue la ayuda.

## Advertencias

- **No** pongas collarines improvisados.
- No la sientes ni le levantes la cabeza para darle de beber.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (restricción de la movilidad de la columna cervical); ERC Guidelines 2021 — Primeros auxilios · **Revisado:** 2026-11-09

# Fracturas y esguinces



> Resumen orientativo. Sin radiografía no se puede distinguir con seguridad un esguince de una fractura: ante la duda, trátalo como una fractura.

## Signos de posible fractura

Dolor intenso, deformidad, hinchazón, imposibilidad de mover o apoyar, crujido al lesionarse.

## Pasos

1. Si hay una hemorragia grave, contrólala primero (protocolo «Hemorragia grave»).
2. **No muevas** la zona lesionada. **No intentes recolocar** el hueso ni enderezar una fractura deformada.
3. **Inmoviliza** en la posición en que esté, incluyendo la articulación de encima y la de debajo: con cartón, revistas enrolladas, tablillas o la otra pierna, almohadillando con ropa. Para el brazo, un **cabestrillo** con un pañuelo.
4. Retira anillos, relojes y pulseras antes de que se hinche.
5. Comprueba que los dedos siguen **calientes y con buen color**; si no, afloja la sujeción.
6. **Fractura abierta** (hueso visible o herida sobre la fractura): cubre la herida con un apósito limpio sin presionar sobre el hueso.
7. Llama al **112** si hay deformidad, fractura abierta, sospecha de lesión en cadera, muslo, pelvis o columna, o si la extremidad está fría, pálida o sin sensibilidad.

## Esguinces leves

- **Reposo** y **elevación** de la zona.
- **Frío** envuelto en un paño (nunca hielo directo sobre la piel) hasta 20 minutos, cada 2–3 horas, los primeros días.
- Si no puede apoyar o no mejora en pocos días, que lo valore un sanitario.

## Advertencias

- No apliques calor ni masajes en los primeros días.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (fracturas y lesiones articulares cerradas); NHS — Sprains and strains; NHS — Broken bones (first aid) · **Revisado:** 2026-11-09

18

PRIMEROS AUXILIOS

# Heridas y prevención de la infección

112

> Resumen orientativo. Para sangrados abundantes usa el protocolo «Hemorragia grave».

## Pasos

1. Lávate las manos y ponte guantes si los tienes.
2. Si sangra, **presiona** con un apósito o una tela limpia hasta que pare. Si el sangrado es abundante o no para, llama al **112** (protocolo «Hemorragia grave»).
3. **Lava la herida con abundante agua potable** a chorro, con jabón alrededor, hasta quitar la suciedad visible.
4. Retira con cuidado los restos superficiales; **no extraigas** objetos clavados.
5. Cubre con un apósito limpio. Cámbialo si se moja o se ensucia.
6. Busca atención sanitaria si es **profunda**, ancha o con bordes separados, si está en la cara, las manos, las articulaciones o los genitales, si es una **mordedura**, si está muy sucia (tierra, óxido) o si no estás seguro de tu **vacunación antitetánica**.
7. **Amputación**: controla la hemorragia, envuelve la parte amputada en una gasa o paño limpio humedecido, métela en una bolsa cerrada y esa bolsa dentro de otra con **agua y hielo**. Llama al **112**, anota la hora y que viaje con la víctima.
8. Vigila en los días siguientes los signos de **infección**: enrojecimiento que se extiende, calor, hinchazón, pus, rayas rojas o fiebre. Si aparecen, consulta con urgencia.

## Advertencias

- **No** pongas la parte amputada en contacto directo con el hielo ni la congeles.
- No pongas remedios caseros (tierra, hierbas, café, pasta de dientes) en la herida: el agua limpia basta para lavarla.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (limpieza de heridas); ERC Guidelines 2025 — Primeros auxilios (conservación de partes amputadas); Ministerio de Sanidad — Recomendaciones de vacunación frente al tétanos · **Revisado:** 2026-11-09

19

PRIMEROS AUXILIOS

# Quemaduras químicas y eléctricas

112

> Resumen orientativo. Protégete primero: no toques el producto ni a una víctima que siga en contacto con la corriente.

## Quemadura química

1. Ponte guantes si puedes. Si el producto es un **polvo**, cepíllalo antes de mojar.
2. Quita la ropa, las joyas y el calzado contaminados.
3. **Lava con abundante agua** a chorro suave durante **al menos 15 minutos**, más si sigue doliendo.
4. **Ojos**: lávalos de inmediato con agua limpia abundante y continua **al menos 15 minutos**, con los párpados abiertos y el ojo afectado hacia abajo para no contaminar el otro. Quita las lentillas si salen con facilidad.
5. Llama al **112** o al **Servicio de Información Toxicológica (91 562 04 20)** y guarda el envase del producto.

## Quemadura eléctrica

1. **Corta la corriente** (cuadro eléctrico, desenchufar) antes de tocar a la víctima. Si no puedes, sepárala con un objeto seco que no conduzca (madera, plástico).
2. **Alta tensión** (líneas, catenarias, subestaciones): no te acerques; llama al **112**.
3. Si no responde y no respira con normalidad: **RCP** y **DEA**.

4. Enfría las quemaduras visibles con agua y cúbrelas con un apósito limpio.
5. Llama al **112** aunque parezca leve: las lesiones internas y las alteraciones del ritmo del corazón pueden no verse.

## Advertencias

- **No** intentes neutralizar el producto con otro (vinagre, bicarbonato).
- Las quemaduras eléctricas suelen tener un punto de entrada y otro de salida: busca ambos.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (quemaduras y lesiones oculares por sustancias químicas); CDC/NIOSH — Pocket Guide to Chemical Hazards (primeros auxilios); Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses — Servicio de Información Toxicológica · **Revisado:** 2026-11-09

# Bajada de azúcar (hipoglucemia)

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025.

## Cuándo sospecharla

Persona con **diabetes** (o desnutrida) que de repente está sudorosa, temblorosa, pálida, confusa, irritable, se comporta de forma extraña o está somnolienta.

## Pasos

1. Si está **despierta y puede tragar**: dale **15–20 g de glucosa** (tabletas o gel de glucosa).
2. Si no hay glucosa: un puñado de **caramelos con azúcar** o **50–100 ml** de zumo de fruta o refresco con azúcar (no «light» ni «zero»).
3. Si hay glucómetro: mide el azúcar. Por debajo de **70 mg/dl (4 mmol/l)**, trátala y vuelve a medir después.
4. Si **a los 15 minutos** no mejora, repite el azúcar.
5. Cuando se recupere, que tome un **tentempié** ligero (pan, galletas, fruta).
6. Si tiene **glucagón prescrito** (inyectable o nasal), puede administrárselo ella misma o una persona formada, según sus instrucciones.
7. En **niños** que no colaboran para tragar: valora poner **media cucharadita de azúcar** (unos 2,5 g) **debajo de la lengua**.

8. Llama al **112** si está o se queda **inconsciente**, si convulsiona o si no mejora.

## Advertencias

- **Nunca** des nada por la boca a una persona inconsciente: puede atragantarse. Si respira, posición lateral de seguridad y llama al 112.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (hipoglucemia) · **Revisado:** 2026-11-09

# Ahogamiento



> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. Muchas personas mueren al intentar un rescate sin formación: no te conviertas en otra víctima.

## Rescate

1. Grita pidiendo ayuda y que alguien llame al **112**.
2. **No entres al agua** si no tienes formación en salvamento. Ayuda desde tierra: lánzale un **objeto que flote** (salvavidas, garrafa vacía, nevera) o acércale una pértiga, una rama o una cuerda.
3. Si eres socorrista y entras: lleva un elemento de flotación y mantén su cabeza fuera del agua.

## Fuera del agua

1. Si **no responde y no respira** con normalidad: da **5 insuflaciones** de rescate y empieza la **RCP** (30 compresiones y 2 insuflaciones).
2. **Seca el pecho** y conecta el **DEA** en cuanto esté disponible.
3. Si respira: posición lateral de seguridad, quítale la ropa mojada y abrígala.

## Advertencias

- **No** intentes sacar el agua de los pulmones (ni compresiones abdominales ni ponerla boca abajo): retrasa la reanimación.
- Si vomita durante la RCP, gírala de lado, limpia la boca y continúa.
- Aunque se recupere, debe valorarla un médico: pueden aparecer problemas respiratorios horas después.

- Si se zambulló en aguas poco profundas, sospecha una lesión de columna.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (ahogamiento) y Situaciones especiales en resucitación · **Revisado:** 2026-11-09

22

PRIMEROS AUXILIOS

# Deshidratación y suero oral casero

112

> Resumen orientativo. Las sales de rehidratación oral de farmacia son preferibles: usa la receta casera solo si no hay otra opción.

## Signos de gravedad (llama al 112 o acude a urgencias)

- Somnolencia, confusión o dificultad para despertarla.
- No orina en muchas horas, ojos muy hundidos, boca muy seca, no puede beber o lo vomita todo.
- Sangre en las heces, fiebre alta, o un bebé con llanto sin lágrimas y pocos pañales mojados.

## Suero oral casero (receta OMS)

1. **1 litro de agua potable** (hervida y enfriada, o tratada: protocolo «Potabilizar agua»).
2. **6 cucharaditas rasas de azúcar**.
3. **Media cucharadita rasa de sal**.
4. Remueve hasta que se disuelva. **No debe saber más salado que las lágrimas.**

## Cómo darlo

1. Da **sorbos pequeños y frecuentes** (con cuchara en niños pequeños). Si vomita, espera 10 minutos y sigue más despacio.

2. Tras cada deposición líquida, como orientación de la OMS: menores de 2 años, **50–100 ml**; de 2 a 10 años, **100–200 ml**; mayores, lo que quieran beber.
3. Sigue con la **lactancia materna** y con la comida habitual en cuanto la tolere.
4. Prepara suero nuevo cada día y desecha el sobrante a las 24 horas.

## Advertencias

- **No** añadas más sal ni más azúcar: un suero mal preparado puede empeorar la deshidratación.
- Los refrescos, zumos y bebidas deportivas no sustituyen al suero oral en una deshidratación por diarrea.

---

**Fuente:** OMS — The treatment of diarrhoea: a manual for physicians and other senior health workers (rehidratación oral, plan A); OMS/UNICEF — Para la vida (Facts for Life), capítulo Diarrea · **Revisado:** 2026-11-09

23

CLIMA

# Hipotermia

112

> Resumen orientativo. La hipotermia grave es una emergencia médica.

## Signos

Temblores intensos, torpeza, confusión y somnolencia. En los casos graves los temblores **cesan**: es peor señal, no mejor.

## Pasos

1. Llama al **112** si hay confusión, somnolencia o pérdida de consciencia.
2. Lleva a la persona a un lugar resguardado del viento, la lluvia y el suelo frío.
3. Retira la ropa **mojada**, sustitúyela por ropa seca y aíslala del suelo.
4. Cúbrela con mantas, un saco de dormir o una manta térmica, incluida la cabeza.
5. Si está **consciente y puede tragar**: bebidas calientes y azucaradas (nunca alcohol).
6. Manipúlala con suavidad y mantenla en horizontal si la hipotermia es grave.

## Advertencias

- **No** frotes las extremidades ni apliques calor directo intenso.
- Si no respira con normalidad: RCP. La hipotermia puede proteger el cerebro; no abandones pronto la reanimación.

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios y circunstancias especiales (hipotermia accidental) · **Revisado:** 2026-11-08

24

CLIMA

# Golpe de calor

112

> Resumen orientativo. El golpe de calor es potencialmente mortal.

## Signos

Temperatura corporal muy alta, piel caliente, confusión, mareo, náuseas, convulsiones o pérdida de consciencia.

## Pasos

1. Llama al **112**.
2. Lleva a la persona a la sombra o a un lugar fresco.
3. **Enfríala de inmediato**. Lo más eficaz es **sumergir el cuerpo** (del cuello hacia abajo) en agua fría. Si no es posible, empápala con agua y abanícala, y aplica compresas frías en el cuello, las axilas y las ingles.
4. Si está consciente y puede tragar: agua o bebida con sales en pequeños sorbos.
5. Si pierde la consciencia y no respira con normalidad: RCP.

## Advertencias

- No retrases el enfriamiento esperando a la ambulancia.
- No le des medicamentos para la fiebre: no son eficaces en el golpe de calor.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (golpe de calor por esfuerzo) · **Revisado:** 2026-11-08

25 CLIMA

# Congelación

112

> Resumen orientativo. Trata primero la hipotermia si la hay: es más peligrosa.

## Signos

Piel blanca, grisácea o amarillenta, fría, dura o cerosa y **sin sensibilidad**, sobre todo en dedos, nariz, orejas y mejillas. Al recalentarse puede doler, hincharse y formar ampollas.

## Pasos

1. Resguarda a la persona del frío y del viento y **trata antes la hipotermia** (protocolo «Hipotermia»).
2. Quítale anillos, relojes y la ropa o el calzado mojado o apretado.
3. **No recalientes si hay riesgo de que se vuelva a congelar**: congelarse de nuevo causa más daño que esperar.
4. Si puedes evitar que se vuelva a congelar, **sumerge** la zona en agua a **37–39 °C** (templada, nunca caliente) hasta que la piel se ablande y recupere el color; suele llevar unos 30 minutos.
5. Si no hay agua templada, deja que se descongele con calor corporal (por ejemplo, en la axila de otra persona).
6. Seca con suavidad, separa los dedos con gasas y cubre con **apósitos limpios y holgados**. No revientes las ampollas.
7. Eleva la zona y busca **atención médica** lo antes posible. Llama al **112** si hay signos de hipotermia, si la zona afectada es extensa o si no puedes llegar por tus medios a un centro sanitario.

## Advertencias

- **No** frotes la zona (ni con nieve ni con las manos): daña aún más los tejidos.
- **No** uses calor directo (fuego, estufa, secador, bolsa muy caliente): la zona insensible se quema.
- Evita caminar con pies ya descongelados salvo que sea imprescindible para ponerse a salvo.

---

**Fuente:** Wilderness Medical Society — Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Treatment of Frostbite (actualización 2024); European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (prevención de la hipotermia) · **Revisado:** 2026-11-09

# Ola de frío y refugio



> Resumen orientativo. Con frío extremo los más vulnerables son las personas mayores, los bebés, quienes no tienen hogar y los enfermos crónicos.

## En casa

1. Calienta **una sola habitación** y reuníos en ella; cierra las demás y tapa las rendijas.
2. Vístete con **varias capas** de ropa holgada, gorro y calcetines; usa mantas.
3. Come caliente y bebe líquidos; evita el alcohol.
4. **Nunca** uses braseros, estufas de exterior, barbacoas ni generadores dentro de casa. Si usas estufas de butano, ventila y apágalas al dormir.
5. Visita o llama a los **vecinos mayores** o que vivan solos.

## Fuera o sin refugio

1. Busca **resguardo del viento** y de la humedad y **aíslate del suelo** con ramas, la mochila o cartón.
2. **Mantente seco**: cámbiate la ropa mojada y evita sudar (quítate capas antes de hacer esfuerzos).
3. Cubre **cabeza, cuello, manos y pies**. En grupo, permaneced juntos para compartir calor.
4. **Atrapado en el coche por la nieve**: quédate dentro; enciende el motor solo a ratos, con el **tubo de escape libre de nieve** y una ventanilla un poco abierta (riesgo de monóxido de carbono).

5. Vigila los signos de **hipotermia** (temblor intenso, torpeza, confusión) y de **congelación** (piel blanca e insensible) y aplica sus protocolos.

## Advertencias

- El alcohol da sensación de calor pero **favorece la hipotermia**.
- Llama al **112** si alguien está confuso, somnoliento o no responde.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (prevención de la hipotermia); Ministerio de Sanidad — Recomendaciones ante bajas temperaturas; CDC — Winter Weather: staying safe; DGT — Recomendaciones para circular con nieve · **Revisado:** 2026-11-09

# Potabilizar agua



> Resumen orientativo. Ningún método elimina contaminantes **químicos** (combustibles, metales, pesticidas): si sospechas contaminación química, busca otra fuente.

## Antes de desinfectar

- Si el agua está **turbia**, déjala reposar y fíltrala con un paño limpio o un filtro de café. Los métodos siguientes funcionan peor con agua turbia.

## Hervir (método preferente)

- Lleva el agua a **ebullición fuerte durante 1 minuto**.
- Por encima de **2000 m de altitud**: **3 minutos**.
- Déjala enfriar tapada y guárdala en recipientes limpios y cerrados.

## Lejía (cloro)

- Usa lejía **apta para desinfección de agua de bebida**, sin perfume ni aditivos (la etiqueta lo indica).
- Con lejía de **~5–6 %** de cloro: **2 gotas por litro** de agua clara (4 si está turbia o fría).
- Mezcla y espera **30 minutos**. Debe quedar un ligero olor a cloro; si no, repite la dosis y espera 15 minutos más.

## Desinfección solar (SODIS)

- Usa botellas de **PET transparente** de hasta 2 litros, limpias y sin arañazos, con agua clara.
- Exponlas al sol directo **6 horas**. Si el cielo está nublado más de la mitad del tiempo, **2 días seguidos**.
- No sirve con lluvia continua ni con agua turbia.

## Advertencias

- Guarda el agua tratada en recipientes limpios y con tapa, y sírvela sin meter las manos ni los vasos.

---

**Fuente:** OMS — Guías para la calidad del agua de consumo humano; CDC — Making Water Safe in an Emergency; EAWAG/OMS — Desinfección solar del agua (SODIS) · **Revisado:** 2026-11-08

28

INTOXICACIONES Y PICADURAS

# Intoxicación por monóxido de carbono

112

> Resumen orientativo. El monóxido de carbono no se ve ni huele: sospéchalo si varias personas del mismo lugar se encuentran mal a la vez.

## Signos y fuentes

Dolor de cabeza, mareo, náuseas, cansancio o confusión, que mejoran al salir y vuelven al entrar. Fuentes habituales: **braseros**, estufas de gas o butano, calderas y calentadores mal ventilados, **generadores**, barbacoas o motores en espacios cerrados.

## Pasos

1. **Sal al aire libre** de inmediato y saca a los demás si puedes hacerlo sin riesgo. Abre puertas y ventanas al salir.
2. Si está a tu paso, apaga el aparato sospechoso; no te entretengas.
3. Llama al **112** desde fuera.
4. **No vuelvas a entrar** hasta que los servicios de emergencia lo autoricen.
5. Si alguien no responde: si respira, **posición lateral de seguridad**; si no respira con normalidad, **RCP**.
6. Todos los expuestos deben ser valorados por un sanitario, en especial **embarazadas, niños, mayores** y quien haya perdido la consciencia, aunque ya se encuentren mejor.

## Advertencias

- No entres a rescatar a nadie en un lugar lleno de humo o gas sin protección: avisa a los bomberos.
- **Nunca** uses generadores, barbacoas, braseros ni estufas de exterior dentro de casa, del garaje o de una tienda de campaña.
- Instala un **detector de monóxido de carbono** y revisa calderas, calentadores y chimeneas.

---

**Fuente:** Ministerio de Sanidad — Intoxicación por monóxido de carbono (prevención); CDC — Carbon Monoxide Poisoning: prevention and first steps; European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Situaciones especiales (intoxicaciones) · **Revisado:** 2026-11-09

# Intoxicación por productos, medicamentos o setas

> Resumen orientativo. Servicio de Información Toxicológica (24 horas): **91 562 04 20**. Si hay síntomas graves, llama antes al **112**.

## Pasos

1. Aleja a la persona del producto y retira lo que le quede en la boca.
2. Si **no responde, le cuesta respirar o convulsiona**: llama al **112**. Si no respira con normalidad, **RCP** (haz solo compresiones si el tóxico puede contaminarte).
3. Si se encuentra bien, llama al **Servicio de Información Toxicológica (91 562 04 20)** y sigue sus indicaciones.
4. Ten a mano el **envase o la etiqueta** (o restos de setas, plantas o pastillas), la **cantidad** aproximada, la **hora** y la edad y el peso de la persona.
5. **Piel**: quita la ropa contaminada y lava con abundante agua. **Ojos**: lávalos con agua al menos 15 minutos.
6. **Gases o humos**: sal al aire libre (protocolo «Intoxicación por monóxido de carbono»).
7. **Setas**: consulta siempre, aunque aún no haya síntomas: en las setas más peligrosas pueden tardar horas en aparecer.
8. **Opioides** (respiración muy lenta, pupilas muy pequeñas, no despierta): llama al **112**, inicia la RCP si no respira con normalidad y usa **naloxona** si está disponible.

## Advertencias

- **No provoques el vómito** ni des leche, agua, aceite u otros remedios salvo que te lo indique un sanitario.
- Con cáusticos (lejía, desatascadores, amoniaco): enjuaga la boca y no la hagas vomitar.
- Guarda productos de limpieza y medicamentos fuera del alcance de los niños y en su envase original.

---

**Fuente:** Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses — Servicio de Información Toxicológica (91 562 04 20, 24 horas); European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Situaciones especiales (intoxicaciones) y Primeros auxilios (sobredosis por opioides) · **Revisado:** 2026-11-09

30

INTOXICACIONES Y PICADURAS

# Mordedura de víbora o serpiente

112

> Resumen orientativo de las guías ERC 2025. La víbora es la única serpiente autóctona muy venenosa en Europa. Cualquier mordedura de serpiente requiere valoración hospitalaria.

## Signos

Dos marcas de colmillos, dolor intenso, hinchazón y amoratamiento que avanzan; a veces náuseas, mareo o malestar general.

## Pasos

1. Aléjate de la serpiente; **no intentes atraparla** ni matarla. Si puedes, hazle una foto desde lejos.
2. Llama al **112**.
3. Mantén a la persona **tranquila y en reposo**, tumbada o sentada.
4. **Inmoviliza** la extremidad mordida, como si fuera una fractura, y mantenla quieta.
5. Retira **anillos, relojes y ropa ajustada** antes de que se hinche.
6. Que la persona **no camine** si se puede evitar. Espera a la ambulancia o sigue las indicaciones del 112.
7. Anota la hora de la mordedura y cómo evolucionan los síntomas.

## Advertencias (no hagas)

- **No** pongas torniquete ni vendaje compresivo.
- **No** apliques hielo ni calor.

- **No** cortes la herida ni intentes **succionar** el veneno.
- No des alcohol ni medicamentos por tu cuenta.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (mordedura de serpiente) · **Revisado:** 2026-11-09

31

INTOXICACIONES Y PICADURAS

# Picaduras de abeja y avispa; garrapatas

112

> Resumen orientativo. Tras cualquier picadura, vigila los signos de reacción alérgica grave (anafilaxia).

## Abeja o avispa

1. Si queda el **aguijón** (abeja), retíralo **cuanto antes** raspando de lado con una uña o el borde de una tarjeta. Evita pellizcarlo.
2. Lava la zona con agua y jabón.
3. Aplica **frío** envuelto en un paño y eleva la zona.
4. Llama al **112** si aparece dificultad para respirar, hinchazón de labios, lengua o garganta, mareo o ronchas por todo el cuerpo: es una **anafilaxia** (usa su autoinyector si lo tiene). También si hay **muchas picaduras** o la picadura es **en la boca o la garganta**.

## Garrapata

1. Retírala **cuanto antes** con unas **pinzas de punta fina**.
2. Sujétala **lo más cerca posible de la piel** y tira hacia arriba con fuerza **constante**, sin girar ni dar tirones.
3. Si queda parte de la boca y no sale con facilidad, déjala y permite que la piel cicatrice.
4. Lava la zona y tus manos con agua y jabón y desinfecta la piel.
5. Anota la fecha. Consulta a un sanitario si en las **semanas siguientes** aparece **fiebre**, malestar o una mancha roja que se extiende.

## Advertencias

- **No** pongas a la garrapata aceite, alcohol, vaselina, esmalte ni calor, ni la aplastes con los dedos.
- Revisa todo el cuerpo (también a niños y mascotas) tras pasear por el campo.

---

**Fuente:** European Resuscitation Council Guidelines 2025 — Primeros auxilios (anafilaxia); NHS — Insect bites and stings; CDC — Tick Removal; Ministerio de Sanidad — Enfermedades transmitidas por garrapatas · **Revisado:** 2026-11-09

32

INTOXICACIONES Y PICADURAS

# Mordeduras de animales (rabia y tétanos)

112

> Resumen orientativo. Toda mordedura de mamífero debe valorarla un sanitario por el riesgo de infección, tétanos y, en algunos casos, rabia.

## Pasos

1. Ponte a salvo del animal; no intentes capturarlo si es peligroso.
2. Si sangra mucho, **presiona** con un apósito limpio, llama al **112** y sigue el protocolo «Hemorragia grave».
3. **Lava la herida de inmediato** con **agua y jabón** a chorro durante **al menos 15 minutos**, aunque sea un arañazo.
4. Si tienes, aplica un **antiséptico** (por ejemplo, povidona yodada) y cubre con un apósito limpio.
5. Acude a un **centro sanitario** el mismo día: valorarán antibiótico, **vacuna antitetánica** y, si procede, **profilaxis antirrábica**.
6. Anota qué animal fue, si tiene dueño y si está vacunado: las autoridades sanitarias pueden necesitar **observar al animal**.
7. Consulta **con urgencia** ante cualquier mordedura, arañazo o contacto con un **murciélago** (en España pueden transmitir el virus de la rabia), con un animal salvaje o de conducta extraña, o con un animal en el extranjero, Ceuta o Melilla.

## Advertencias

- **No cierres** la herida por tu cuenta ni la tapes con remedios caseros.

- No toques con las manos desnudas un murciélago ni un animal sospechoso, vivo o muerto; avisa al 112.
- Vigila los signos de infección (enrojecimiento que se extiende, pus, fiebre) en los días siguientes.

---

**Fuente:** OMS — Rabia, nota descriptiva (primeros auxilios de la herida); Ministerio de Sanidad — Protocolo de actuación ante mordeduras y profilaxis antirrábica (murciélagos); Ministerio de Sanidad — Recomendaciones de vacunación frente al tétanos · **Revisado:** 2026-11-09

33

DESASTRES Y ENTORNO

# Incendio en casa o en un edificio

112

> Resumen orientativo. El humo mata antes que las llamas: sal cuanto antes y no vuelvas a entrar.

## Pasos

1. Avisa a gritos a todos y **sal de inmediato**. No te entretengas en coger objetos.
2. Llama al **112** en cuanto estés fuera.
3. Si hay humo, **avanza agachado o a gatas**, cerca del suelo, y tápate la boca y la nariz con un paño, mejor húmedo.
4. Antes de abrir una puerta, **tócala con el dorso de la mano**: si está caliente, no la abras y busca otra salida.
5. **Cierra las puertas** detrás de ti para frenar el fuego y el humo.
6. **No uses el ascensor**; baja por la escalera. Si la escalera está llena de humo, no la uses.
7. Si no puedes salir: enciérrate en una habitación con ventana, **sella las rendijas** de la puerta con toallas o ropa mojada y **hazte ver** desde la ventana. Di al 112 dónde estás.
8. Si se te prende la ropa: **detente, tírate al suelo y rueda**, cubriéndote la cara. Después enfría las quemaduras con agua.

## Advertencias

- Usa un extintor solo si el fuego es **pequeño** y tienes la salida a tu espalda.

- **No** eches agua a un fuego de aceite ni a uno eléctrico: tapa la sartén con una tapa y corta la corriente.
- Fuera, reuníos en un punto acordado y **no vuelvas a entrar** a por nada ni por nadie: avisa a los bomberos.

---

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones ante incendios en el hogar; NFPA — Escape planning; European Resuscitation Council Guidelines 2021 — Primeros auxilios (quemaduras) · **Revisado:** 2026-11-09

34

DESASTRES Y ENTORNO

# Incendio forestal

112

> Resumen orientativo. Sigue siempre las órdenes de evacuación o de confinamiento de las autoridades: salir a tiempo es la opción más segura.

## Si ves fuego o humo

1. Llama al **112**: di dónde estás (coordenadas del GPS) y qué ves.
2. **Aléjate** en dirección contraria al avance del fuego y al viento, hacia zonas **sin vegetación**, carreteras, ríos o zonas ya quemadas.
3. **No huyas ladera arriba** ni por barrancos: el fuego sube muy rápido por las pendientes.
4. En coche: enciende las luces, conduce despacio y **no atravieses el fuego ni el humo denso**.
5. Si el fuego te alcanza en el coche: para en una zona despejada, cierra ventanillas y ventilación y **quédate dentro**, agachado bajo las ventanillas y cubierto con una manta, hasta que pase el frente.
6. Si te ves rodeado a pie: busca una **zona ya quemada** o sin combustible. Moja tu ropa y cúbrete la boca y la nariz con un paño húmedo.
7. Como último recurso: túmbate en una zanja, un hoyo o tras una roca, con la cara cubierta.

## Si estás en casa y no te han evacuado

1. Cierra puertas y ventanas y aparta cortinas y objetos inflamables de ellas.
2. Llena bañeras y cubos de agua; moja los alrededores si es posible.

3. Ten lista la mochila de emergencia y el coche orientado hacia la salida. Atiende la radio y los avisos **ES-Alert** del móvil.

## Advertencias

- No hagas fuego ni barbacoas en el monte y no tires colillas ni vidrios.
- No vuelvas a la zona hasta que lo autoricen: el fuego puede reavivarse.

---

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones ante incendios forestales; 112 Castilla-La Mancha y Junta de Andalucía (Plan INFOCA) — Consejos de autoprotección; Country Fire Authority (Victoria, Australia) — Survival in a vehicle · **Revisado:** 2026-11-09

# Terremoto



> Resumen orientativo. La mayoría de las lesiones se deben a objetos que caen y a intentar salir corriendo durante la sacudida.

## Durante la sacudida

1. **Agáchate, cúbrete y agárrate**: ponte de rodillas, protégete bajo una mesa resistente (o junto a una pared interior, cubriéndote la cabeza y el cuello con los brazos) y sujétate hasta que pare.
2. **Aléjate de ventanas**, espejos, estanterías, lámparas y fachadas.
3. Si estás **dentro, quédate dentro**: no corras hacia la salida ni uses el ascensor o la escalera mientras tiembla.
4. Si estás **fuera**: aléjate de edificios, postes, árboles y cables eléctricos.
5. **Conduciendo**: detente en un lugar despejado, lejos de puentes, túneles y taludes, y quédate en el coche.
6. En la **costa**, si la sacudida es fuerte o larga o el mar se retira de forma anómala: ve **de inmediato a un lugar elevado** o tierra adentro, sin esperar avisos (riesgo de **tsunami**).

## Después

1. Espera **réplicas**. Revisa si hay heridos y presta primeros auxilios. Llama al **112** si hay heridos graves o personas atrapadas.
2. Si hueles a gas, **no enciendas** nada: cierra la llave de paso y sal (protocolo «Fuga de gas»).
3. Sal con calzado y con cuidado si el edificio tiene daños; no uses el ascensor.

4. Usa el teléfono solo para emergencias e infórmate por la radio y los canales oficiales.

## Advertencias

- No te refugies bajo el marco de una puerta: en las viviendas modernas no protege más que otras zonas.
- No vuelvas a un edificio dañado hasta que lo revisen los técnicos.

---

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones ante terremotos; Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Qué hacer en caso de terremoto; CDC — Directrices de seguridad durante un terremoto · **Revisado:** 2026-11-09

# Inundación



> Resumen orientativo. Muchas muertes por inundación se producen al intentar cruzar con el coche o al bajar a garajes y sótanos: busca **altura**, no tu coche.

## Ante un aviso

1. Atiende los avisos de **AEMET** y Protección Civil y las alertas **ES-Alert** del móvil.
2. Sube a las **plantas altas** la documentación, los objetos de valor y la mochila de emergencia.
3. Prepárate para evacuar y sigue las órdenes de las autoridades.

## Durante la inundación

1. Sube a un **piso alto** o a la azotea. **No bajes a garajes, sótanos** ni plantas bajas, tampoco a sacar el coche.
2. **Corta la electricidad y el gas** si puedes hacerlo sin pisar agua.
3. **No cruces** calles, vados ni puentes inundados, ni a pie ni en coche: unos 15 cm de agua en movimiento pueden derribarte y unos 30 cm pueden arrastrar la mayoría de los coches.
4. Si el coche queda atrapado y el agua sube, **sal de él** y busca un lugar alto.
5. Aléjate de cauces, barrancos y ramblas, aunque estén secos.
6. Llama al **112** si estás en peligro y di exactamente dónde estás.

## Después

- No bebas agua del grifo hasta que lo autoricen; si dudas, potabilízala (protocolo «Potabilizar agua»).
- Evita el contacto con el agua de la inundación (puede estar contaminada o electrificada) y no uses aparatos eléctricos que se hayan mojado.

---

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones ante inundaciones; AEMET — Avisos meteorológicos (Meteoalerta); NOAA National Weather Service — Turn Around Don't Drown · **Revisado:** 2026-11-09

37

DESASTRES Y ENTORNO

# Tormenta eléctrica y rayos

112

> Resumen orientativo. Ningún lugar al aire libre es seguro durante una tormenta eléctrica.

## Pasos

1. Si **oyes truenos**, ya estás al alcance de los rayos: **busca refugio de inmediato**, sin esperar a que llueva.
2. Refúgiate en un **edificio** o en un **coche** de techo metálico con las ventanillas cerradas.
3. Aléjate de **árboles aislados**, cimas, crestas, torres, postes y vallas metálicas.
4. Sal del **agua** (playa, piscina, río) y aléjate de la orilla.
5. Suelta los objetos metálicos largos (bastones, paraguas, herramientas) y baja de la bicicleta o la moto.
6. En grupo al aire libre, **separaos** unos metros entre vosotros.
7. Si no hay refugio: agáchate en una zona baja con los **pies juntos** y la cabeza baja, sin tumbarte en el suelo. Es un último recurso: no protege del todo.
8. Espera **al menos 30 minutos** desde el último trueno antes de salir.

## Si alguien recibe un rayo

- Puedes **tocarla**: no queda electricidad en el cuerpo. Llama al **112**.
- Si no respira con normalidad: **RCP** y **DEA**. Si hay varias víctimas, atiende primero a las que **no respiran**.

## Advertencias

- Dentro de casa, evita la ducha, los grifos y los aparatos con cable conectados durante la tormenta.
- No te refugies en cuevas pequeñas ni bajo salientes de roca.

---

**Fuente:** AEMET — Recomendaciones ante tormentas; NOAA National Weather Service — Lightning Safety; CDC — Lightning safety tips; European Resuscitation Council Guidelines — Situaciones especiales (lesiones por rayo) · **Revisado:** 2026-11-09

38

DESASTRES Y ENTORNO

# Apagón prolongado

112

> Resumen orientativo. En un apagón prolongado los mayores riesgos son el fuego (velas), el monóxido de carbono (generadores, braseros) y los alimentos en mal estado.

## Pasos

1. Usa **linternas** con pilas en lugar de velas. Si usas velas, no las dejes nunca sin vigilancia.
2. **Desenchufa** los aparatos sensibles (ordenador, televisor) para protegerlos cuando vuelva la luz; deja una lámpara encendida para saber cuándo vuelve.
3. Infórmate con una **radio** a pilas o de manivela. Llama al **112** solo para emergencias reales.
4. Ahorra **batería del móvil**: modo ahorro, brillo bajo y datos desactivados salvo para lo imprescindible.
5. Mantén **cerrados el frigorífico y el congelador**: el frigorífico conserva el frío unas **4 horas**; un congelador lleno, unas **48 horas** (24 si está a medias).
6. Ten reservas de **agua**: el bombeo puede fallar, sobre todo en pisos altos.
7. Comprueba cómo están los **vecinos mayores** o dependientes y quienes usan equipos médicos eléctricos.
8. Evita los ascensores y conduce con precaución: los semáforos pueden no funcionar.

## Advertencias

- **Nunca** uses generadores, barbacoas, hornillos de camping ni braseros en interiores: riesgo de **monóxido de carbono**.
- Desecha los alimentos perecederos que hayan estado a más de 4 °C durante más de 2 horas.
- Si dependes de un equipo médico eléctrico, ten un plan alternativo y comunícalo a tu centro de salud.

---

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones ante un apagón eléctrico; Comisión Europea — Estrategia de la Unión de Preparación (2025); FoodSafety.gov (EE. UU.) — Alimentos y cortes de electricidad; CDC — Carbon Monoxide Poisoning · **Revisado:** 2026-11-09

39

DESASTRES Y ENTORNO

# Fuga u olor a gas

112

> Resumen orientativo. El gas doméstico lleva un olor añadido (a huevos podridos o «a gas») para poder detectar las fugas.

## Pasos

1. **No enciendas ni apagues** luces ni aparatos eléctricos, no toques timbres ni enchufes y **no hagas llamas** (cerillas, mecheros, tabaco).
2. **Abre puertas y ventanas** para ventilar.
3. **Cierra la llave de paso** del gas o la válvula de la bombona de butano.
4. **Sal de la vivienda** con todas las personas y animales.
5. **Llama desde fuera** al **112** o al teléfono de urgencias de tu distribuidora de gas. No uses el teléfono dentro.
6. Avisa a los vecinos llamando a su puerta con los nudillos, no al timbre.
7. No vuelvas a entrar hasta que los bomberos o un técnico lo autoricen.

## Advertencias

- **No** uses el ascensor ni el portero automático.
- Si hay alguien mareado o inconsciente, sácalo al aire libre solo si puedes hacerlo sin riesgo, y llama al 112.
- Si ya hay fuego, no intentes cerrar una bombona en llamas: sal y llama al 112.

**Fuente:** Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones de autoprotección en el hogar (gas); Distribuidoras de gas natural y butano en España — Instrucciones de seguridad ante olor a gas · **Revisado:** 2026-11-09

40

DESASTRES Y ENTORNO

# Kit de emergencia para 72 horas

112

> Resumen orientativo. La Unión Europea recomienda poder valerse por uno mismo al menos **72 horas** tras una emergencia. Revisa el kit de vez en cuando (caducidades, pilas, medicación).

## Agua y comida

- **Agua**: unos **3 litros por persona y día** para beber y cocinar (mínimo 1,5 litros solo para beber). Para 3 días, unos 9 litros por persona.
- **Comida no perecedera** que no necesite cocinarse: conservas (con abrelatas manual), frutos secos, barritas, galletas.
- Comida para bebés y mascotas si los hay.

## Luz, energía y comunicación

- **Radio** a pilas o de manivela, **linterna** (mejor frontal) y pilas de repuesto.
- **Batería externa** cargada y cable del móvil.
- Un **silbato** para pedir ayuda.

## Salud e higiene

- **Botiquín** de primeros auxilios y **medicación habitual** para varios días, con copia de las recetas.
- Gel desinfectante, toallitas, bolsas de basura, papel higiénico y mascarillas.

- Pastillas potabilizadoras o lejía apta para agua de bebida.

## Documentos y otros

- **Copias de documentos** (DNI, tarjeta sanitaria, seguros) en una bolsa estanca.
- **Dinero en efectivo** en billetes pequeños: los datáfonos y cajeros pueden no funcionar.
- Llaves de repuesto, mechero o cerillas, navaja multiusos, cinta americana, manta térmica, ropa de abrigo y calzado cómodo.
- Lista en papel con **teléfonos de contacto** y un **punto de encuentro** acordado con la familia.

## Advertencias

- Guarda el kit en un lugar fácil de coger al salir y asegúrate de que todos en casa saben dónde está.
- El kit no sustituye a pedir ayuda: ante cualquier emergencia con heridos o peligro, llama al **112**.

---

**Fuente:** Comisión Europea — Estrategia de la Unión de Preparación (2025, autosuficiencia mínima de 72 horas); Protecció Civil de Catalunya — Kit de emergencia; Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) — Recomendaciones de autoprotección · **Revisado:** 2026-11-09

41

DESASTRES Y ENTORNO

# Pedir ayuda y señales de socorro

112

> Resumen orientativo. Si puedes llamar, el **112** es siempre la primera opción.

## Llamar al 112

1. Llama al **112**: funciona en toda la UE y puede usar otra red móvil si la tuya no tiene cobertura.
2. Di **dónde estás** (coordenadas del GPS), qué ha pasado y cuántas personas sois. Muchos móviles envían además su ubicación automáticamente al llamar.
3. Si la cobertura es mala, prueba desde un punto más alto y ahorra batería entre llamadas.

## Señales sin teléfono

1. **Señal de socorro en montaña**: **6 señales por minuto** (silbato, linterna o gritos, una cada 10 segundos), un minuto de pausa y repetir. La respuesta de los rescatadores son 3 señales por minuto.
2. **SOS** con luz o sonido: **3 cortas, 3 largas, 3 cortas**.
3. **Hacia un helicóptero o avión**: de pie, con los **dos brazos en alto en forma de Y** significa «necesito ayuda»; un brazo arriba y otro abajo, «no necesito ayuda».
4. **Señales en el suelo**, grandes y contrastadas (piedras, ramas, ropa): **V** = necesito ayuda; **X** = necesito asistencia médica.
5. De día, refleja el sol con un **espejo** o una superficie brillante hacia el aparato. De noche, usa la linterna.

## Advertencias

- **Quédate en un lugar visible** y, si te has perdido, no sigas caminando sin rumbo: es más fácil que te encuentren.
- Lleva ropa de colores vivos o extiende algo llamativo en el suelo.
- No hagas fuego para hacer señales si hay riesgo de incendio forestal.

---

**Fuente:** Servicio 112 (UE) y localización avanzada de emergencias (AML); Comisión Internacional de Socorro Alpino (IKAR-CISA) — Señal internacional de socorro en montaña; OACI — Anexo 12, Búsqueda y salvamento (señales tierra-aire y corporales) · **Revisado:** 2026-11-09